PROCESO[1]

GESTIONAR LA ASISTENCIA SANITARIA A TRAVÉS DEL CENTRO COORDINADOR DE URGENCIAS (CCU)

Fecha de elaboración	Versión	Fecha prevista de revisión
JULIO 2019	1.0	JULIO 2021

MISIÓN[2]

Proporcionar la respuesta más adecuada a las demandas asistenciales sanitarias de los ciudadanos, teniendo en cuenta el lugar y contexto en el que se produce y los recursos disponibles para satisfacer dicha demanda de un modo rápido, coordinado, efectivo y equitativo.

Enfoque	Punto de vista
General	Organización Pública

ALCANCE[3]

Límite de Entrada	Límite de Salida
Población general, profesionales sanitarios (Atención Primaria o Especializada) y no sanitarios (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil,..) que solicitan asistencia sanitaria de urgencias o emergencias.	▪ Resolución de la demanda sanitaria a través de consulta médica/enfermera. ▪ Derivación del usuario a los centros sanitarios pertinentes (centro de salud, SUAP, hospital). ▪ Asignación de recursos para la asistencia en el lugar de la demanda y derivación del usuario al destino que su situación requiera. ▪ Transporte Interhospitalario.

CLIENTES[4]

1. Usuario de la asistencia	
Necesidades y expectativas	▪ Asistencia sanitaria de urgencias o emergencias ▪ Seguridad en la actuación ▪ Efectividad en la resolución ▪ Atención personalizada ▪ Información adecuada ▪ Toma de decisiones consensuada ▪ Intercomunicación entre los niveles asistenciales y continuidad en la atención
2. Llamante que activa la demanda asistencial (familiar, viandante, observador,..)	
Necesidades y expectativas	▪ Efectividad en la resolución del proceso ▪ Información sobre la situación
3. Profesionales Sanitarios (Atención Primaria y Especializada) y no Sanitarios (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado)	

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:04
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-eef7e71f-ce45-e4d7-0147-0050569b6280

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

Necesidades y expectativas	▪ Atención efectiva a la urgencia y emergencia extrahospitalaria ▪ Intercomunicación entre los niveles asistenciales y continuidad en la atención ▪ Actitud de colaboración
4. SUAP, UME y otros servicios sanitarios movilizados por CCU (ANA, VIR, PAC, PEA, Cruz Roja y Alfa de Protección Civil)	
Necesidades y expectativas	▪ Gestión adecuada de los recursos ▪ Tipificación adecuada y actualizada del nivel de demanda sanitaria. ▪ Información suficiente sobre la demanda sanitaria ▪ Información suficiente al llamante sobre el contexto en que se produce la demanda, los recursos disponibles y el tiempo de espera aproximado ▪ Comunicación efectiva entre las bases emisora-receptora y soporte de traslado interhospitalario
5. Centros Sanitarios Públicos y Privados de otras Comunidades Autónomas	
Necesidades y expectativas	▪ Traslado interhospitalario urgente y programado extracomunitario ▪ Comunicación efectiva entre las bases emisora-receptora y soporte de traslado interhospitalario
6. Dirección General de Protección Civil y Emergencias	
Necesidades y expectativas	▪ Gestión de emergencias sanitarias recibidas en la central regional del 112 ▪ Participación en dispositivos especiales y planes de emergencia regionales (PLATEMUR) y sus planes asociados; COPLA, DISACA (Dispositivo Sanitario Cobertura Autoridades), DRP (Dispositivo Riesgo Previsible)

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:04
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-eef7e71f-ce45-e4d7-0147-0050569b6280

Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia
C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta
30005 Murcia
AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001
AENOR Transporte Sanitario UNE 179002
Puesto y firma:
Director Gerente 061.
D.Francisco Celdrán Gil
(Documento firmado electrónicamente al margen)

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

DIAGRAMA DE CONTEXTO (A-0). GESTIONAR LA ASISTENCIA SANITARIA A TRAVÉS DE CCU

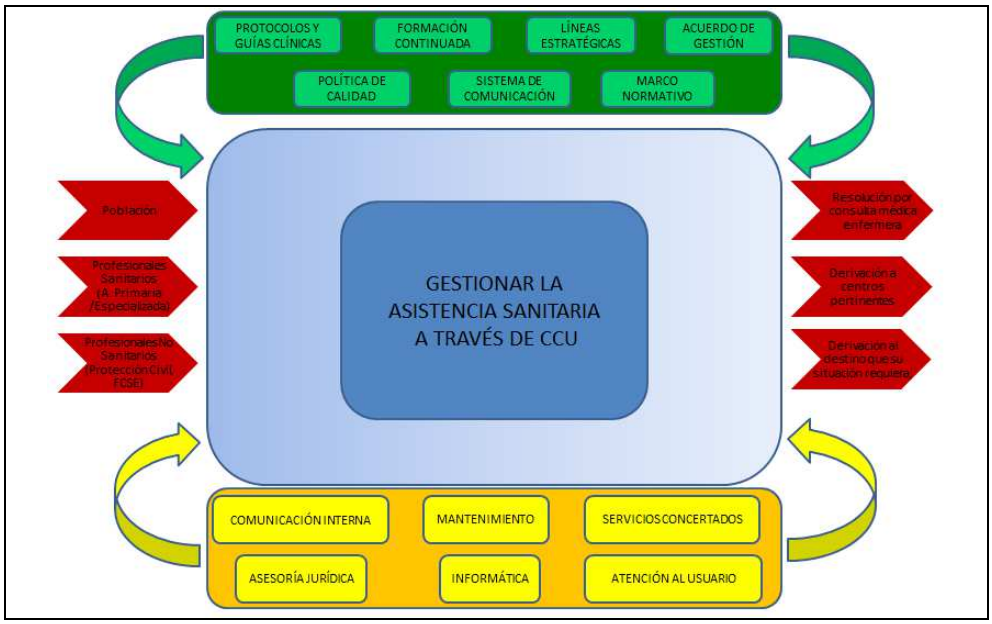
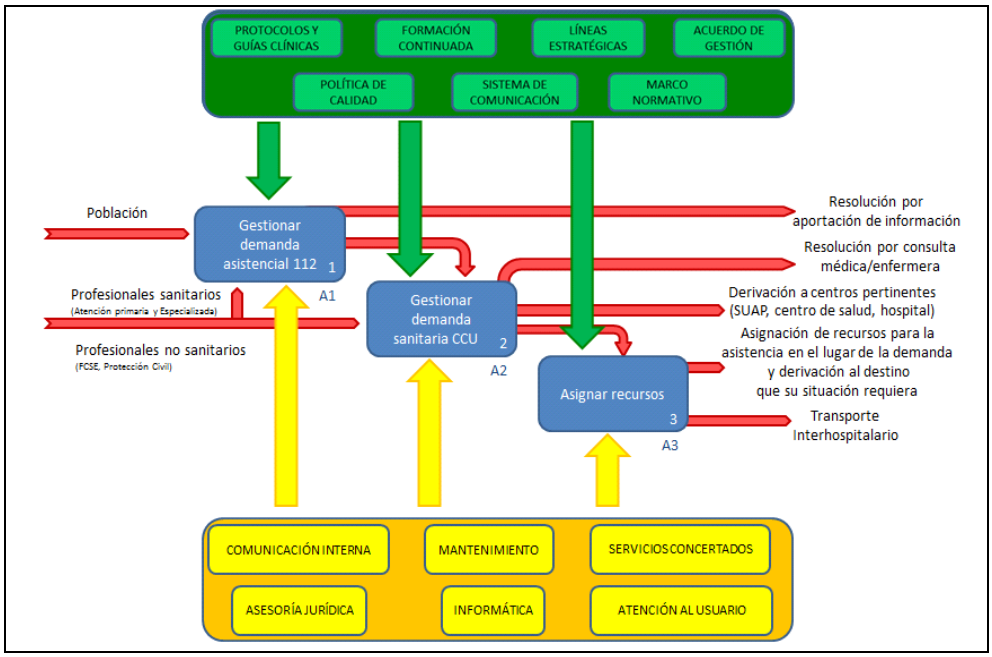


DIAGRAMA A0. GESTIONAR LA ASISTENCIA SANITARIA A TRAVÉS DE CCU



CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:04
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-eef7e71f-ce45-e4d7-0147-0050569b6280

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

ARBOL NODAL[5]

0. GESTIONAR LA ASISTENCIA SANITARIA A TRAVÉS DE CCU
A1.Gestionar la demanda asistencial desde 112
A11. Abrir carta de llamada (PA)
A12. Registrar motivo de llamada
A121. No asistenciales
A1211. No pertinentes
A1212. Informativos, agradecimientos, sugerencias, quejas y reclamaciones
A1213. Organismos
A1214. Otros
A122. Asistenciales
A1221. Tipificar la demanda sanitaria
A12211. Emergencia Sanitaria (A1)
A12212. Urgencia demorable (A2)
A12213. Urgencia no crítica (A3)
A12214. No urgentes: programados, avisos domiciliarios y altas de centros sanitarios (A4)
A12215. Consulta médica (M2)
A1222. Pasar la información al CCU
A12221. El operador 112 pasa la información al CCU
A12222. El médico/enfermera solicita la información a través del botón "transferencia de llamada"
A2. Gestionar la demanda sanitaria CCU
A21. Acceder a la carta de llamada
A22. Continuar la gestión telefónica
A23. Registrar información en la carta de llamada
A231. Apartado "medidas"
A232. Apartado "recursos"
A233. Apartado "estado de los recursos"
A234. Modificar la tipificación en base a nueva información o actualización
A24. Codificación
A241. Consulta médica
A2411. Se resuelve
A2412. Se convierte en un aviso
A2413. Se deriva a una centro sanitario (centro de salud, SUAP u hospital)
A242. Movilización UME
A243. Movilización SUAP
A244. Movilización otros servicios sanitarios
A245. Derivación del usuario en traslado no asistido a un centro sanitario
A246. Derivación del usuario por sus propios medios a otro servicio sanitario
A3. Asignar recursos
A31. Movilización UME
A32. Movilización SUAP
A33. Movilización otros servicios sanitarios (VIR, PAC, PEA, Cruz Roja, Alfa de Protección Civil)
A34. Movilizar servicios concertados para derivar al usuario a un centro sanitario

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:04
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-eef7e71f-ce45-e4d7-0147-0050569b6280

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

PROCEDIMIENTOS[6]

A1. Gestionar la demanda asistencial desde el 112

El teleoperador del 112 recibe la demanda telefónica de asistencia, abre una carta de llamada y registra el motivo de la misma. El motivo de la demanda puede ser: "No sanitario" y eso significa que no requiere de la intervención de los recursos que coordina la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, o bien puede ser "Sanitario" y en este caso los motivos de llamada quedan registrados como: asistencia sanitaria (A), consulta médica (M), seguridad ciudadana – accidentes de tráfico con víctimas y heridos (P) y bomberos: incidentes con víctimas (B).

Cuando el motivo de la demanda es "No Sanitario", éste se clasifica en:

- No pertinente. Aquí el teleoperador explica al llamante las razones por las cuales considera que la demanda no es pertinente e informa hacia dónde debe dirigir su demanda.
- Informativas, agradecimientos, sugerencias, quejas y reclamaciones referidas a la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Aquí el teleoperador informa al llamante de la existencia del teléfono 968 394 811 y del correo sau.061.sms@carm.es como medio de contacto con la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia.
- Organismos (centros de salud, PAC, SUAP, policia local, etc.). Aquí el teleoperador tipifica la demanda como "información organismo 061", reflejando en COM TS el motivo de la consulta, transfiriendo esta a un profesional del CCU según su criterio.
- Otras. Aquí el teleoperador utiliza su más amplio y profesional criterio, registrando la causa y objetivo de la llamada. En caso de considerarlo oportuno puede solicitar la colaboración del personal del CCU para resolver la demanda.

En el caso de tratarse de una demanda "Sanitaria", el siguiente paso es tipificar la llamada pudiendo tener los siguientes resultados: emergencia sanitaria (A1), urgencia demorable (A2), urgencia no crítica (A3), no urgentes como programados, avisos domiciliarios y altas de centros sanitarios (A4) y consulta médica (M2).

Una vez tipificada la demanda, la información pasará al CCU a través de 2 vías posibles: en la primera el teleoperador del 112 pasa la información de forma ordinaria al CCU, en la segunda forma es el médico o la enfemera del CCU quien solicita y recibe la información a través del botón "transferencia de llamada".

A2. Gestionar la demanda asistencial sanitaria desde CCU

Todo el personal de CCU (médico, enfermera y TES) tiene acceso a la carta de llamada desde el momento en que queda clasificada como asistencia sanitaria, de tal forma que se continúa con la gestión telefónica y el registro de la información pertinente en los apartados "medidas", "recursos", "estado de los recursos" y, sobre todo, se permite la modificación en la tipificación de la demanda sanitaria en base a información nueva o actualizada.

A continuación, se procede a la codificación en función de los recursos que son necesarios activar y estos pueden ser:

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:04
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-eef7e71f-ce45-e4d7-0147-0050569b6280

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

- Consulta médica. Aquí el médico o la enfermera del CCU dan cobertura a las consultas sanitarias de los ciudadanos y las posibles salidas pueden ser: resolver el motivo de la consulta, convertir la consulta en otra carta de llamada o finalmente derivar al usuario al centro sanitario apropiado (centro de salud, SUAP u hospital). Como el médico y la enfermera son personal del CCU, no se consideraría como recurso a movilizar, por tanto quedarían circunscritos al subproceso "Gestionar la demanda sanitaria CCU".
- Movilización UME. La UME normalmente se moviliza ante la demanda sanitaria tipificada como A1 y A2.
- Movilización SUAP. Normalmente el recurso SUAP se moviliza ante una demanda sanitaria tipificada entre A2 y A4, aunque en aquellos casos en los que la UME está ocupada, el SUAP puede activarse para dar cobertura a una demanda del tipo A1.
- Movilización de otros servicios sanitarios. Estos recursos pueden ser: VIR (vehículo de intervención rápida), PAC (punto de atención continuada), PEA (punto de especial aislamiento), Cruz Roja o Alfa de Protección Civil.
- Derivación del usuario en traslado no asistido a un centro sanitario. Aquí se suele utilizar el recurso de ambulancia no asistencial (ANA) que recoge al usuario y lo deriva a un centro sanitario (SUAP u hospital).
- Derivación del usuario por sus propios medios a otro servicio sanitario. Este es el caso en que las circunstancias y las condiciones del usuario permiten su derivación por sus propios medios a un centro sanitario (SUAP u hospital).

A3. Asignar recursos

Finalmente, el personal del CCU tras gestionar la demanda sanitaria, asigna los recursos necesarios en función de la necesidad y disponibilidad y estos serían los siguientes:

- Movilización UME/SUAP (conforman un proceso asistencial propio).
- Movilización de otros servicios sanitarios. Estos recursos pueden ser: VIR (vehículo de intervención rápida), PAC (punto de atención continuada), PEA (punto de especial aislamiento), Cruz Roja o Alfa de Protección Civil.
- Derivación del usuario en traslado no asistido a un centro sanitario. Aquí se suele utilizar el recurso de ambulancia no asistencial (ANA) que recoge al usuario y lo traslada a un centro sanitario (SUAP u hospital).
- Traslado Interhospitalario.

OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL PROCESO[7]

1. Proporcionar la respuesta más adecuada a las demandas asistenciales sanitarias de los ciudadanos.
2. Consulta médica o enfermera.
3. Gestión del transporte sanitario primario urgente asistencial y no asistencial.
4. Gestión del transporte sanitario secundario crítico, tanto provincial como interprovincial.

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:04
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-eef7e71f-ce45-e4d7-0147-005056986280

5. Información sanitaria: direcciones, teléfonos, centros de salud de referencia, hospitales, etc.
6. Gestión de operativos especiales: dispositivo de riesgo previsible (DRP), dispositivo sanitario de cobertura a autoridades (DISACA), plan COPLA, código Infarto, código ICTUS y neonato crítico.
7. Seguimiento de incidentes sanitarios complejos abiertos.
8. Información y consejo sobre problemas de Salud Pública y Epidemiológicos.
9. Gestión sanitaria de las grandes emergencias o catástrofes.

INDICADORES[8]

Grupo[9] 1. Indicadores de actividad.	
Código	Nombre del indicador
1.01.	Número de llamadas atendidas CCU
1.02.	Número de llamadas con asignación de recurso asistencial
1.03.	Número de llamadas resueltas con consejo médico/enfermera
1.04.	Número de actuaciones con intervención UME
1.05.	Número de actuaciones con intervención SUAP
1.06.	Número de actuaciones con intervención PAC
1.07.	Número de actuaciones VIR
1.08.	Número de actuaciones asignadas a Cruz Roja y Protección Civil
Grupo 2. Accesibilidad.	
Código	Nombre del indicador
2.01.	Tiempo invertido desde la gestión de la llamada hasta la activación del recurso
2.02.	Tiempo invertido desde que se asigna el recurso hasta la activación de la unidad
2.03.	Tiempo invertido desde la activación a la llegada al lugar de la unidad para prioridad A1
2.04.	Tiempo invertido desde la activación a la llegada al lugar de la unidad para prioridad A2
2.05.	Tiempo invertido desde la asignación de un transporte interhospitalario urgente a la mesa de transporte hasta la asignación del recurso
Grupo 3.Seguridad.	
Código	Nombre del indicador
3.01.	Nivel de satisfacción en relación al tiempo de espera desde la llamada al 112 hasta la llegada del equipo sanitario (encuesta de satisfacción al usuario)
3.02.	Nivel de satisfacción global con la atención recibida por el 061
3.03.	Tasa de cumplimentación de la carta de llamada
3.04.	Registro de agresiones a profesionales del CCU
Grupo 4. Calidad científico-técnica.	
Código	Nombre del indicador
4.01.	Tasa de avisos con prioridad A1 que son trasladados a hospital
4.02.	Tasa de llamadas clasificadas como PCR en las que se realiza RCP telefónica guiada

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:04
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-eef7e71f-ce45-e4d7-0147-0050569b6280

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/

4.03.	RCP telefónica adecuada a protocolo
4.04.	Tasa de RCP telefónica en las que se mantiene en línea al llamante hasta llegada de la unidad
4.05.	Registro del destino del paciente al alta en asistencias UME
4.06.	Registro del destino del paciente al alta en asistencias SUAP
4.07.	Registro del destino del paciente al alta en asistencias ANA
4.08.	Codificación diagnóstica CIE-9 en ECHO2, asistencias UME
4.09.	Codificación diagnóstica CIE-9 en ECHO2, asistencias SUAP
4.10.	Número de avisos que se quedan en situación "en cola" previamente a ser asignados.
Grupo 5.Satisfacción.	
Código	Nombre del indicador
5.01.	Satisfacción en el Área de Urgencias Extrahospitalarias 061 (encuesta de satisfacción usuarios)
5.02.	Accesibilidad en el Área de Urgencias Extrahospitalarias 061 (encuesta de satisfacción usuarios)
5.03.	Nivel de calidad percibido por el profesional (encuesta de satisfacción al profesional)
5.04.	Tasa de reclamaciones dirigidas a CCU

[1] Nombre del proceso. Utilizar un formulario para cada proceso.
[2] Función o tarea básica que desempeña el proceso
[3] Delimitar la extensión del proceso explicitando sus competencias, desde dónde hasta dónde va a actuar
[4] Persona o conjunto de personas que reciben y valoran lo que les llega desde el proceso, explicitando sus necesidades (lo que es necesario para resolver/gestionar el problema) y expectativas (lo que esperan que les suceda/exista)
[5] Detallar (desde lo más global hasta lo más concreto) qué tiene que hacer el proceso para conseguir su misión.
[6] Detallar cómo se harán las cosas que previamente se ha acordado que el proceso debe hacer.
[7] Listar qué queremos conseguir con la puesta en marcha de este proceso, no cuantificar estas metas.
[8] Aspecto relevante que resume en la medida lo posible un aspecto del proceso que deseamos monitorizar, utilizado no para medir sino sobre todo como herramienta para comprobar su conformidad con un valor estándar.
[9] Categoría que agrupa a varios indicadores, por lo general en relación con los objetivos de gestión del proceso

CELDRAN GIL, FRANCISCO 03/09/2019 14:25:04
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-ee17e711-ce45-e4d7-0147-0050569b6280

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 Murcia. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en http://10.181.8.6/intranet/